Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Não-Me-Toque

Rua Padre Valentim Rumpel, 220 - Bairro: Centro - CEP: 99470000 - Fone: (54) 30469890 - Email: frnaometoqvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001687-51.2022.8.21.0112/RS

AUTOR: FRANCISCO CORREA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - Relatório (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil).

FRANCISCO CORREA, qualificado na inicial, ajuizou *ação para tutela da saúde com pedido de tutela provisória de urgência* em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE**, igualmente qualificados, aduzindo que é portador de Neoplasia Maligna da Próstata (CID 10 C61), necessitando fazer uso do fármaco *enzalutamida* 40mg, na quantia de 04 (quatro) comprimidos ao dia, totalizando 120 (cento e vinte) comprimidos ao mês. Destacou que caso não seja submetido ao tratamento, haverá piora em seu quadro clínico. Referiu que não reúne condições financeiras de adquirir a medicação prescrita sem prejuízo do próprio sustento. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos que amparam a pretensão. Pugnou a concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar aos entes públicos demandados o imediato fornecimento do tratamento, na quantidade especificada ou então recursos para aquisição do medicamento. No mérito, requereu a procedência do feito, com a confirmação da tutela provisória de urgência. Pleiteou a concessão da gratuidade judiciária e instruiu a inicial com documentos (Ev. 1).

Recebida a inicial, indeferida antecipação de tutela e ordenada a citação dos réus (Ev. 3).

Citado (Ev. 6), o Município de Não-Me-Toque ofereceu contestação. Defendeu a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, afirmando que no caso dos autos não é possível tomar conhecimento dos rendimentos do núcleo familiar do paciente. Discorreu sobre os critérios fixados pelo STJ por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 106. Ponderou sobre os impactos do fornecimento do tratamento pleiteado nos cofres públicos. Destacou a vedação à aquisição de medicamentos pelo nome comercial e a necessidade de adoção de medidas de contra cautela. Ao final, requereu a improcedência do feito (Ev. 8).

Houve réplica (Ev. 11).

A parte autora distribuiu recurso Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (Ev. 12).

Concedida antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Não-Me-Toque o fornecimento do medicamento em favor da agravante, sob pena de bloqueio de valores. Ainda, restou ordenada a intimação da parte autora para promover a inclusão da União no polo passivo do feito, sob pena de extinção do processo (Ev. 13).

A parte autora postulou pelo encaminhamento dos autos à Justiça Federal (Ev. 23).

Diante da instauração do Incidente de Assunção de Competência nº 14 pelo STJ, onde restou determinado que os Juízes estaduais deixem de praticar qualquer ato de declinação de competência até o julgamento definitivo do incidente, restou ordenada a intimação dos réus para fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial, sob pena de sequestro de valores (Ev. 25).

A parte autora apresentou embargos de declaração (Ev. 31).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul ofereceu contestação. Em preliminar, sustentou que a incumbência do tratamento em questão não cabe ao Estado, pois de disponibilização pelos CACONs, com responsabilidade da União. Argumentou a ilegitimidade passiva do Estado com responsabilidade exclusiva da União. No mérito, ressaltou que o tratamento do câncer é feito pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs. Frisou que a parte autora já estava recebendo atendimento junto a hospital credenciado à rede pública para fornecimento de tratamento oncológico. Pleiteou o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, alternativamente, a improcedência (Ev. 35).

A parte autora postulou pelo bloqueio de valores para aquisição do medicamento (Ev. 37).

Houve réplica (Ev. 39).

Os embargos de declaração apresentados ao Ev. 31, pela parte autora, foram acolhidos (Ev. 40).

A parte autora noticiou a regularização no fornecimento do medicamento, bem como postulou pelo julgamento da lide.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

II - Fundamentação (art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil).

Do julgamento antecipado

Diante dos limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável a dilação probatória, sendo suficiente o que já se encontra anexado aos autos. Assim, passo ao julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil[1].

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Refuto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado do Rio Grande do Sul.

A parte autora ingressou com o presente feito visando a dispensação, pelos réus, do fármaco enzalutamida 40mg, cujo pedido restou acolhido em sede de tutela antecipada recursal. E, embora o Estado alegue a responsabilidade da União, que dispensa tratamento oncológico através dos CACONs, isso não afasta a sua responsabilidade solidária em fornecê-lo.

É sabido que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes de maneira solidária, independentemente do medicamento constar na lista de um deles apenas, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva de determinado ente. É dever dos Estados, modo solidário com os demais entes da Federação (Municípios e União), fornecer o(s) medicamento(s) postulado(s) pela parte autora, já que o direito à saúde, como essencial que é e outorgado pela Constituição Federal de modo universal, há de ser atendido de plano, sendo de eficácia imediata a regulação constitucional.

Em se tratando de responsabilidade solidária, pode a parte requerente demandar contra quaisquer dos entes, seja União, Estado ou Município e, no caso de condenação ao final, o ente poderá buscar ressarcimento com a União administrativamente ou em demanda própria, se assim preferir.

Ainda, o fato de o medicamento não constar na lista do Estado, de forma alguma serve para elidir sua legitimidade no presente feito, já que a saúde não pode estar limitada por uma lista formulada pelo Estado/Município para atender casos mais genéricos.

Nesse sentido, há julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO. ECA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO "A QUO". DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO A SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ADEQUADA AO TRATAMENTO. Pedido. Caso em que o menor, com dois anos e nove meses de idade quando ajuizada a ação, postula o fornecimento de procedimento cirúrgico, pois portador de CATARATA MONOCULAR NO OLHO DIREITO (CID 10 H 26.0). APELO DO MUNICÍPIO Não conhecimento do recurso. Caso em que o Município não recorreu de decisão do juízo "a quo" que não conheceu do recurso de apelação interposto. Assim, preclusa esta decisão é de rigor o não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Gravataí. APELO DO ESTADO Preliminarmente: Legitimidade passiva e Solidariedade. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. No mérito: Direito à saúde e Prescrição médica adequada ao tratamento. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista constitucional, é bem de ver que em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa ao princípio da legalidade. Por fim, os documentos médicos já constantes dos autos são suficientes para comprovar a necessidade do menor em receber o procedimento cirúrgico pleiteado. NÃO CONHECERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. (Apelação Cível Nº 70063112403, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 12/02/2015)*
>
> *AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Litisconsórcio necessário com a União. Inocorrência. Cabe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. In casu, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Município para figurar no polo passivo da presente demanda, condenando-o, solidariamente, ao fornecimento do fármaco ora pleiteado. Responsabilidade pelo fornecimento de tratamento para o câncer. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade - sob pena de arcar com os custos do tratamento -, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). Custas e despesas processuais. Nos termos do artigo 11, do Regimento de Custas (Lei nº 8.121/82, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010), está a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas e emolumentos, devendo, no entanto, arcar com as despesas, salvo as oriundas de Oficial de Justiça, nos termos da ADIn Nº 70038755864. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70063108153, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 25/02/2015)*

Outrossim, o fato de existirem Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs e UNACONs) mantidos pela União Federal não afasta a responsabilidade dos demais entes públicos (REsp n.º 1182710, Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado em 18/03/2010; REsp n.º 1097942, Ministro LUIZ FUX, publicado em 13/11/2008), orientação que prevalece neste Tribunal: AI Nº 70034454843, SANDRA BRISOLARA MEDEIROS; AC nº 70031543200, FRANCISCO JOSÉ MOESCH; e Agravo nº 70034726943, CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO).

Neste mesmo sentido o STJ, relativamente ao fornecimento do medicamento para câncer, em caso específico de tratamento de câncer de mama, já decidiu, *verbis*:

> *PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. TRASTUZUMABE (HERCEPTIN). PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA (CID 10). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 196. COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A matéria em discussão foi analisada pelo Tribunal a quo sob o enfoque constitucional, levando-se em consideração o Direito à Saúde, descabendo a esta Corte Superior o exame da controvérsia, sob pena de invasão da competência do STF. 3. Quanto à responsabilidade de cada ente público, percebe-se que o entendimento da Corte de origem está em conformidade com o do STJ, de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1561510/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 31/05/2016).*

Diante disso, afasto a preliminar arguida pelo réu e reconheço sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

<u>Do mérito</u>

O artigo 196 da Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, dever este que vem corroborado também no artigo 198, §1º, e no artigo 23, inciso II, da Carta Magna, bem como no artigo 241 da Constituição Estadual:

> *"**Art. 23.** É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;*
>
> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. **<u>(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)</u>."***
>
> *"**Art. 241.** A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação."*

Além disso, a saúde é direito fundamental, elencado dentro dos direitos sociais (artigo 6º, *caput,* da Constituição Federal[2]), e, assim, possui aplicação imediata e incondicionada, na forma do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, dispositivo que a ela se estende.

Portanto, é plenamente possível exigir de todos ou de qualquer um dos entes (União, Estado ou Município) - que possuem responsabilidade solidária – os medicamentos nos casos de extrema necessidade e por aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas correspondentes - como é o caso da parte autora que recebe valores mensais de aproximadamente 01 salário-mínimo a título de aposentadoria (evento 1, CHEQ5).

Nessa direção, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente, proferido sob o rito do art. 543-C do anterior Código de Processo Civil:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. **O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.** (RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015).*

Além disso, tal tema foi inúmeras vezes objeto recorrente em julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente ora colacionado:

> *Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. **Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.** Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). Grifei.*

Mister registrar que não se pode admitir que o Judiciário reste inerte no caso de descumprimento da lei, devendo intervir se for impulsionado. Não há, portanto, violação à independência dos poderes quando da concessão de medicamentos judicialmente.

Não fosse por isso, a precária situação no orçamento do Estado não pode justificar a negativa a um direito à saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), que deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS

> *EMBARGOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA E INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. As despesas com a saúde para pessoas carentes devem correr por conta dos recursos destinados ao fundo de desenvolvimento social do estado (Leis Estaduais 9.908/93 e 9.828/93). Saúde é direito de todos e dever do estado e do município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da c. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- rel. Min. Marco Aurélio). O artigo 196 da Constituição Federal não faz distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e todos, indistintamente, são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, sendo certo que a descentralização, mera técnica de gestão, não importa compartimentar sua prestação. Embargos acolhidos, por maioria. (Embargos Infringentes Nº 70030244370, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 19/06/2009).*
>
> *AGRAVO. APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público o medicamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de medicamentos a necessitado, devendo responder pelos medicamentos pleiteados no processo. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação ao Município, sendo a Defensoria Pública um órgão do Estado do Rio Grande do Sul e a ação ajuizada também contra Município, ausente confusão entre credor e devedor. Agravo desprovido. (Agravo Nº 70039339122, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/11/2010)*

Na hipótese dos autos, o fármaco pleiteado não integra a lista de medicamentos fornecidos no âmbito do SUS, não constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 - RENAME. Assim, aplicam-se ao caso as teses fixadas por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 106 do STJ. Quando do julgamento do respectivo tema, o STJ fixou as seguintes teses:

> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:*
> *i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> *ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> *iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Com efeito, entendo que a parte autora atendeu aos requisitos para o fornecimento de medicamento não integrante das listas do SUS. De acordo com o laudo médico acostado ao evento 1, LAUDO10, o paciente já havia sido submetido a 06 ciclos de quimioterapia, com controle parcial da doença. Porém, apresentou toxicidade, sendo a *enzalutamida* o fármaco indicado para o controle da doença que acomete o demandante.

Do mesmo modo, o atestado médico acostado ao evento 1, ATESTMED9 revela que o tratamento com *enzalutamida* em pacientes com Adenocarcinoma de Próstata demonstrou aumento de sobrevida livre de progressão, não havendo outra medicação disponível que possa substituir o fármaco prescrito.

Portanto, resta demonstrado por laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, a necessidade de fornecimento da medicação, bem como a ineficácia de outros tratamentos disponibilizados na rede do SUS.

A incapacidade financeira do demandante é notória, sobretudo se considerado o custo mensal para aquisição da medicação, que gira em torno de R$ 15.000,00, conforme referido na petição inicial.

Além disso, o fármaco em questão possui registro ativo até o ano de 2029 na Anvisa[3].

Outrossim, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a paciente tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão. Por seu turno, não produziu a parte demandada prova capaz de contrapor o atestado, no sentido de que a autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado.

Dessarte, restam preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Por fim, observando-se o que estabelece o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde[4], de 15/5/2014, ressalto a necessidade do paciente apresentar relatórios médicos periodicamente perante a Secretaria de Saúde.

Dessa feita, procede a presente demanda para, confirmando a tutela de urgência concedida em sede recursal, determinar que os réus forneçam o medicamento *enzalutamida* 40mg, na quantia indicada nos atestados, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado e Município para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil).

Logo, procede a pretensão autoral.

Por fim, quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, convenço-me que atualmente se mostra possível a sua condenação em honorários advocatícios, que passam a ser devidos à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, superando-se o teor da Súmula 421 do STJ que parte da premissa de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado do Estado ou da União, sem qualquer autonomia. Isso ocorre, pois a EC 45/2004 incluiu o § 2º ao art. 134 conferindo autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais. Veja o dispositivo que foi acrescentado:

Art. 134 (...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Essa autonomia já foi reconhecida pelo STF algumas vezes, como no exemplo abaixo:

(...) I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º).

II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. (...)

STF. Plenário. ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012.

Embora o § 2º somente mencione as Defensorias Públicas Estaduais, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal não foram contempladas, de modo que, mesmo após a EC 45/2004, continuaram subordinadas ao Poder Executivo. Essa distorção foi corrigida com a EC 74/2013, que incluiu o § 3º ao art. 134 da CF/88 com a seguinte redação:

Art. 134 (...)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

Diante disso, atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada como um mero órgão da Administração Direta. A Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88), o que a faz ter o *status* de órgão autônomo.

Como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional, devendo ser efetuada sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 168 da CF/88.

Apesar de existirem decisões do STF reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública, faltava a Suprema Corte analisar, de forma específica, a questão dos honorários de acordo com as emendas constitucionais acima mencionadas. Isso aconteceu no julgamento da AR 1937 AgR. O STF decidiu que é possível a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Vejamos as palavras do Ministro Relator Gilmar Mendes:

"Percebe-se, portanto, que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida (...)"

Vejamos a ementa do julgado:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017.

A decisão do STF foi tomada em um caso envolvendo DPU e União. Vale ressaltar, no entanto, que o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro, como é o caso dos autos. Assim, adotando entendimento constitucional, em conformidade com o entendimento exarado pelo STF, entendo restar superado o vetusto enunciado do 421 do STJ, sendo possível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Esclareço que o valor dos honorários não é repassado para os Defensores Públicos, sendo repassado para um Fundo destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

Dessa forma, procede a pretensão autoral.

III - Dispositivo (art. 489, inciso III, do Código de Processo Civil)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido deduzido na ação movida por **FRANCISCO CORREA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE**, para o fim de condenar os réus a fornecerem ao favorecido, solidariamente, o medicamento *enzalutamida* 40mg, de acordo e na quantia indicada nos atestados juntados ao feito, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado e do Município para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil). Atente-se ao Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Sucumbente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao FADEP, os quais arbitro em R$ 400,00, fulcro no artigo 85, §2° e 3°, II, do CPC. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA (REsp. nº 1.270.439/PR) a partir da publicação desta decisão, acrescidos de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Diante do ajuizamento da presente demanda após a entrada em vigor da Lei estadual nº 14.634/14, resta o réu isento da taxa única, a

teor do artigo 5º, inciso I, que não abarca as despesas processuais (artigo 14 da referida Lei), que deverá restituir em caso de adiantamento pela outra parte, inclusive a título de Taxa única, observando-se, ainda, a tese recentemente firmada no IRDR n° 15 do TJRS (processo n° **70081233793)**[5]**.**

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil[6], intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, sem a sua interposição, **dispensável o reexame necessário**, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos[7].

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada intimação eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIO CESAR SFREDO MONTEIRO, Juiz de Direito**, em 10/1/2023, às 18:7:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10030985786v19** e o código CRC **4fbe33b3**.

---

1. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; ↩
2. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000) ↩
3. 177170006 ↩
4. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28564:jornada-aprova-45-enunciados-para-auxiliar-em-decisoes-da-justica-na-area-da-saude>. Acesso em: 25/5/2014. ↩
5. "A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS INSTITUÍDA PELA LEI 14.634/2014, CONCEDIDA AOS ENTES PÚBLICOS QUE ENUNCIA, APLICA-SE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOREM PARTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE AUTORES OU RÉUS, RESSALVADA A OBRIGAÇÃO, QUANDO SUCUMBENTES, DE REEMBOLSAR AO VITORIOSO AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ESTE TENHA EXPERIMENTADO PARA ESTAR EM JUÍZO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA EM QUESTÃO". ↩4. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
6. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
7. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 DA CF E 241 DA CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO, AO FADEP. REDUÇÃO. CABIMENTO. [...].. REEXAME NECESSÁRIO: Descabe reexame necessário quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior Competente, consoante determina o parágrafo 3º, do art. 475, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065928178, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROSSO, OSTEOBAN, ARTROLIVE E LYRICA. PACIENTE PORTADORA DE POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA E OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID-10 M15.9 E M81.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO, FORNECIDO PELO SUS. DESCABIMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Reexame necessário. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença que determinou o fornecimento de medicamentos está fundada em decisão do plenário do STF. [...]. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066300096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...].. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066248014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiç Julgado em 08/09/2015) ↩